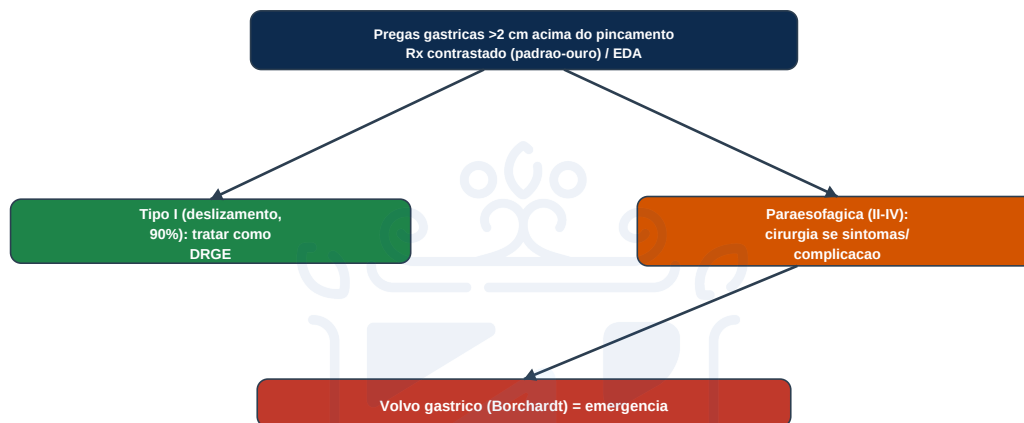


HÉRNIA DE HIATO — TIPO I x PARAESOFÁGICA

FLUXOGRAMA — TIPO GUIA A CONDUTA

HÉRNIA DE HIATO — DESLIZAMENTO x PARAESOFÁGICA



DEFINIÇÃO E FISIOPATOLOGIA

O QUE É

- Migração de parte do estômago para o tórax através do hiato esofágico; prevalência ~10% da população
- Fisiopatologia: alargamento do hiato, aumento da pressão intra-abdominal, encurtamento esofágico
- Pode predispor à DRGE e causar disfagia por impactação do bolo (alteração anatômica)
- Diagnóstico: RX contrastado é o padrão-ouro; EDA mostra pregas gástricas > 2 cm acima do pinçamento diafragmático
- Muitas são assintomáticas e achado incidental

CLASSIFICAÇÃO

Tipo	Características
I — Deslizamento (90%)	JEG e parte do estômago deslizam para o tórax; associada a DRGE
II — Paraesofágica (rolamento)	JEG no lugar; fundo gástrico hernia ao lado do esôfago
III — Mista	JEG deslocada para o tórax + grande porção gástrica
IV — Complexa	Outras vísceras (côlon, delgado, baço, pâncreas); risco de VOLVO gástrico

RED FLAG — VOLVO GÁSTRICO (TRÍADE DE BORCHARDT)

EMERGÊNCIA

- Dor epigástrica/torácica intensa e súbita
- Ânsia de vômito SEM exteriorizar conteúdo (vômito improdutivo)
- Impossibilidade de passar sonda nasogástrica
- Essa tríade sugere VOLVO gástrico (mais comum nas hérnias tipo IV) — risco de estrangulamento/isquemia
- Conduta: descompressão (tentativa de SNG), estabilização e CIRURGIA de urgência

TRATAMENTO

Situação	Conduta
Tipo I (deslizamento)	Mesmo princípio do tratamento da DRGE (medidas + IBP); cirurgia se DRGE refratária
Paraesofágica assintomática	Seguimento
Paraesofágica c/ obstrução (disfagia/volvo)	Cirurgia (hérnia + funduplicatura)
Úlcera de Cameron / refluxo	Cameron -> cirurgia; refluxo -> tratamento de DRGE

MODELO DE REGULAÇÃO / ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA ENCAMINHAMENTO

- Paciente ____ anos com ____ (refluxo/disfagia/dor); hérnia de hiato tipo ____ (RX/EDA).
- Sinais de Borchardt (dor + ânsia improdutiva + impossibilidade de SNG): ____ (volvo?).
- Conduta: tratamento de DRGE (tipo I) / cirurgia (paraesofágica sintomática); emergência se volvo.
- Encaminhamento à cirurgia URGENTE se volvo/estrangulamento; eletiva se paraesofágica sintomática.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é o tipo mais comum de hérnia de hiato?

- A) Tipo II (paraesofágica por rolamento)
- B) Tipo I (por deslizamento)
- C) Tipo III (mista)
- D) Tipo IV (complexa)
- E) Todos igualmente frequentes

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

A tríade de Borchardt (dor epigástrica, ânsia de vômito improdutivo e impossibilidade de passar SNG) sugere:

- A) DRGE leve
- B) Volvo gástrico (emergência)
- C) Úlcera duodenal
- D) Gastrite
- E) Acalásia

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual o tratamento da hérnia de hiato tipo I (deslizamento) sintomática?

- A) Cirurgia para todos
- B) Mesmo princípio do tratamento da DRGE (medidas + IBP)
- C) Antibiótico
- D) Apenas observação sempre
- E) Esofagectomia

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual é o exame padrão-ouro para o diagnóstico de hérnia de hiato?

- A) Endoscopia digestiva alta
- B) Radiografia contrastada (esofagografia/EED)
- C) Manometria
- D) pHmetria
- E) Ultrassom

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Hérnia paraesofágica com disfagia por obstrução alimentar. Qual a conduta?

- A) Apenas IBP
- B) Tratamento cirúrgico
- C) Observação indefinida
- D) Dieta líquida permanente
- E) Antibiótico

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A hérnia de hiato tipo I (por deslizamento) é a mais comum (~90%), com a JEG e parte do estômago deslizando para o tórax; associa-se à DRGE.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A tríade de Borchardt (dor epigástrica + ânsia de vômito improdutiva + impossibilidade de passar SNG) sugere volvo gástrico, emergência com risco de estrangulamento.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A hérnia tipo I sintomática é tratada como DRGE (medidas antirrefluxo + IBP); a cirurgia fica para casos refratários ou paraesofágicas complicadas.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O RX contrastado (esofagografia) é o padrão-ouro para o diagnóstico de hérnia de hiato; a EDA mostra as pregas gástricas acima do pinçamento diafragmático.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Hérnia paraesofágica com obstrução alimentar (disfagia/volvo) tem indicação cirúrgica; assintomáticas podem ser apenas acompanhadas.

SM24
Suporte ao Plantão Médico